

CONSULTA DE DOLOR

Fichas-algoritmo de valoración rápida

Anamnesis dirigida • exploración esencial • ecografía básica • bloqueos • tratamiento • seguimiento

PRINCIPIO RECTOR

No identificar una técnica, sino el generador más probable, descartar lo peligroso y elegir el siguiente paso que cambie la conducta.

Contenido	Áreas incluidas	Formato de uso
Orientación inicial	Cuello • lumbar • hombro • rodilla • cadera • codo • mano-muñeca • tobillo-pie • sacroilíaca • nociplástico	Cuatro fichas por área: orientar, explorar, decidir y prescribir
Apoyo común	Banderas rojas • farmacología • terapia física	Checklist antes de prescribir o infiltrar
Comunicación	Objetivo, expectativas y reevaluación	Frases breves para explicar el plan al paciente

Diseñadas para Curro • versión 2.3 con anamnesis y exploración guiadas, pautas y volúmenes

Documento profesional de apoyo. No sustituye el juicio clínico, la ficha técnica, los protocolos locales ni la formación específica para cada procedimiento.

0. Algoritmo universal: 90 segundos antes de localizar el dolor

La intensidad no decide por sí sola una infiltración; mandan gravedad, función, sueño, progresión, fenotipo y preferencias.

Paso	Pregunta / acción	Si es positivo
1. Urgencia	Fiebre, inmunosupresión, cáncer, pérdida de peso, trauma, dolor nocturno no mecánico, articulación caliente, déficit progresivo, esfínteres/anestesia en silla de montar.	Detener algoritmo: estudio urgente, analítica/imágenes o derivación.
2. Fenotipo	¿Predomina dolor mecánico, inflamatorio, neuropático/radicular o nociplástico?	No mezclar tratamientos: nombrar el fenotipo dominante y los secundarios.
3. Generador	¿Qué postura, carga o movimiento reproduce y qué lo alivia? ¿Local, referido o dermatómico?	Formular 1 diagnóstico probable + 2 imitadores.
4. Función	¿Qué no puede hacer? ¿Duerme? ¿Camina? ¿Trabaja? ¿Qué objetivo concreto tiene?	Usar esa tarea como medida de respuesta, además de EVA/NRS.
5. Confirmación	¿La exploración y la imagen son concordantes? ¿Un bloqueo cambiaría la conducta?	Bloquear solo si el resultado positivo o negativo conduce a decisiones distintas.

SEMÁFORO

VERDE: dolor tolerable y función conservada → educación + ejercicio. ÁMBAR: dolor moderado/persistente o limita rehabilitación → optimizar diagnóstico, medicación breve y valorar intervención compartida. ROJO: dolor incapacitante, déficit, sospecha infecciosa/traumática/tumoral o fracaso con progresión → estudio/derivación prioritaria.

Fenotipo	Pistas rápidas	No olvidar
Mecánico	Carga/movimiento dependiente, rigidez breve, mejora relativa con reposo o cambio de postura.	La imagen degenerativa puede ser incidental.
Inflamatorio	Rigidez matutina prolongada, reposo empeora, calor/tumefacción, síntomas sistémicos.	Cristales, infección y enfermedad reumática.
Neuropático/radicular	Quemazón, descarga, parestesias, alodinia; distribución neuroanatómica y signos neurológicos.	Dolor referido no equivale a radiculopatía.
Nociplástico	Dolor desproporcionado/difuso, hipersensibilidad, sueño/fatiga, múltiples síntomas.	Evitar escalada de técnicas sobre hallazgos incidentales.

1A. Hombro: anamnesis dirigida

Preguntar primero por el movimiento doloroso, el comportamiento nocturno, la movilidad y las pistas cervicales o traumáticas.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele al elevar el brazo, sobre todo al llegar a la horizontal o entre 60° y 120°?	Dolor relacionado con manguito/espacio subacromial.	Reduce este patrón, pero no excluye tendinopatía o rotura.	Arco doloroso, Hawkins-Kennedy, Neer, Jobe y ecografía.
¿Le duele por la noche o al acostarse sobre ese hombro?	Manguito, BSASD, capsulitis u OA; dato frecuente y poco específico.	Reduce irritabilidad nocturna, no lesión estructural.	Movilidad activa/pasiva y fuerza del manguito.
¿Puede moverlo usted menos de lo que yo consigo moverlo pasivamente?	Rotura relevante, inhibición por dolor o neuropatía.	Hace menos probable pseudoparálisis por manguito.	Comparar movilidad activa/pasiva, fuerza y drop-arm.
¿También está rígido cuando otra persona le mueve el brazo, especialmente al rotarlo hacia fuera?	Capsulitis adhesiva u OA glenohumeral.	Reduce capsulitis/OA rígida; pensar más en manguito.	Rotación externa pasiva, patrón capsular y RX si procede.
¿El dolor está arriba del hombro y aparece al cruzar el brazo o llevar una bolsa?	Articulación acromioclavicular sintomática.	Reduce AC como generador principal.	Palpación AC y cross-body adduction.
¿Tiene dolor de cuello, hormigueos o cambia el dolor al mover el cuello?	Radiculopatía cervical o dolor referido.	Reduce origen cervical, pero no lo excluye.	Spurling, distracción, ULTT, Bakody y neurología.
¿Empezó tras un traumatismo con debilidad súbita o incapacidad para elevar el brazo?	Rotura aguda de espesor completo, fractura o luxación.	Reduce lesión traumática mayor.	RX/eco-RM y derivación preferente según hallazgos.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

La anamnesis debe separar un patrón subacromial, una articulación rígida, una rotura con debilidad verdadera y un origen cervical. El dolor nocturno aislado no localiza la estructura.

1B. Hombro: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Arco doloroso	Abducción activa lenta de 0° a 180° y descenso.	Dolor habitual aprox. 60°-120°; aumenta sospecha de dolor relacionado con manguito/espacio subacromial.	Reduce esa sospecha, pero no excluye tendinopatía ni rotura.
Hawkins-Kennedy	Flexión 90°, codo 90°; estabilizar escápula y llevar pasivamente a rotación interna.	Dolor anterolateral habitual: apoya dolor subacromial/manguito; no identifica bursa frente a tendón.	Disminuye algo la probabilidad; no descarta lesión del manguito.
Neer	Estabilizar escápula; elevar pasivamente el brazo en flexión con rotación interna.	Dolor anterolateral habitual: apoya síndrome subacromial clínico.	No excluye manguito; interpretar con arco y fuerza.
Jobe / full can	Brazo a 90° en plano escapular; pulgar abajo o arriba; resistir descenso.	Dolor: supraespinoso sintomático. Debilidad verdadera: sospechar rotura o neuropatía.	Fuerza indolora reduce rotura relevante, no elimina tendinopatía pequeña.
ER lag sign	Codo 90°; colocar casi en rotación externa máxima y pedir mantener al soltar.	El brazo cae hacia rotación interna: sugiere rotura relevante de infraespinoso/supraespinoso posterior.	Hace menos probable una rotura posterosuperior grande; no excluye parcial.
Belly-press / lift-off	Presionar abdomen sin llevar codo atrás; o separar dorso de mano de zona lumbar.	Compensación, debilidad o incapacidad: lesión relevante del subescapular.	Reduce rotura grande; sensibilidad limitada para lesiones pequeñas.
Cross-body adduction	Elevar brazo a 90° y aducirlo pasivamente sobre el tórax.	Dolor focal superior sobre AC: apoya articulación acromioclavicular.	Hace menos probable AC sintomática, pero no la excluye.
Drop-arm	Abducir pasivamente a 90° y pedir descenso lento y controlado.	Caída brusca/incapacidad: sospechar rotura grande o inhibición intensa; confirmar con imagen.	No descarta rotura, especialmente parcial o compensada.

SÍNTESIS CLÍNICA

Ninguna maniobra aislada diagnostica bursitis o rotura. Combinar localización del dolor, movilidad activa/pasiva, fuerza y 2-3 pruebas concordantes. Si hay parestesias, dolor cervical o reflejos alterados, aplicar la ficha cervical.

1C. Hombro: ecografía, intervención y plan

La ecografía completa debe explicar la concordancia clínica, no convertir cualquier hallazgo degenerativo en el generador.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Bíceps largo	Centrado en corredera, patrón fibrilar conservado, sin líquido/hiperemia patológica; valoración dinámica.
Subescapular	Continuidad y fibrilaridad en rotación externa; sin defecto focal ni calcificación relevante.
Supraespinoso	Continuidad hasta huella, grosor/ecogenicidad conservados, sin defecto bursal o articular.
Infraespinoso / redondo menor	Fibrilaridad y huella conservadas; sin atrofia evidente.
BSASD	Sin distensión ni engrosamiento significativo; correlación dinámica, no diagnosticar por una cifra aislada.
AC y receso posterior	Cambios AC, derrame glenohumeral y cortical ósea; describir solo lo visible.

Escenario	Intervención posible	Después
Dolor subacromial que impide dormir/rehabilitar	Una infiltración BSASD ecoguiada puede aportar alivio corto; evitar series automáticas y la inyección intratendinosa.	Iniciar carga progresiva de manguito y estabilizadores escapulares en la ventana analgésica.
Dolor crónico intenso de hombro / capsulitis / OA	Bloqueo supraescapular como coadyuvante seleccionado; infiltración glenohumeral si el generador es articular.	Medir movilidad y función; no añadir bloqueo supraescapular de rutina a toda bursitis.
Tendinopatía calcificante sintomática concordante	Lavado/barbotaje ecoguiado o ESWT según tipo/tamaño/fase, experiencia y preferencias.	Revisión precoz por posible reagudización y rehabilitación progresiva.
Rotura completa, joven/deportista, trauma o debilidad	No vender PRP como reparación. Ecografía/RM y valoración traumatológica; una infiltración bursal puede enmascarar sin resolver.	Decisión compartida sobre reparación vs manejo conservador.

PLAN BASE

Ejercicio activo 6-12 semanas: control de carga, movilidad, fuerza progresiva del manguito, serrato anterior y trapecio; fisioterapia supervisada al inicio si hay miedo, técnica deficiente o gran limitación. ESWT: opción sobre todo en tendinopatía calcificante. EMTT/Magnetolith: coadyuvante de evidencia aún emergente, nunca sustituto del ejercicio.

MENSAJE AL PACIENTE

La infiltración no reconstruye el tendón. Buscamos bajar el dolor el tiempo suficiente para recuperar sueño, movimiento y fuerza; la parte que mantiene la mejoría es la readaptación progresiva.

1D. Hombro: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Manguito / bursitis	Diclofenaco gel 11,6 mg/g: 2-4 g, 3-4 veces/día; si precisa vía oral: ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250 mg/12 h.	Gel 7-14 días; AINE oral 5-7 días y revisar.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días; no mantener si no aporta función.
Calcificación reactiva	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días; reevaluar si dolor intenso persiste.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
BSASD	Betametasona depot (Celestone Cronodose) 1 mL; puede asociarse lidocaína 1% según compatibilidad/protocolo.	Total habitual 4-5 mL. Extrabursal/intratendinoso: no.
Glenohumeral	Betametasona depot 1 mL o triamcinolona 20-40 mg + lidocaína 1% o bupivacaína 0,25%.	Total 5-8 mL; aspirar y confirmar diana.
Supraescapular	Ropivacaína 0,2% o bupivacaína 0,25%; sin corticoide de rutina.	5 mL; ajustar si bloqueo distal/proximal y vigilar toxicidad acumulada.
Barbotaje	Lidocaína 1% para piel/bursa + suero salino 0,9% para lavado; corticoide bursal opcional al final.	LA 5-10 mL; lavado 10-30 mL en alícuotas, no como bolo tisular.

REHABILITACIÓN

Programa 6-12 semanas: movilidad, manguito, deltoides, serrato y trapecio; 4-8 sesiones supervisadas si necesita aprendizaje o progresión.

EVITAR

Corticoide intratendinoso, series programadas, PRP como 'reparación' de rotura completa o bloqueo supraescapular automático para toda bursitis.

2A. Rodilla: anamnesis dirigida

Distinguir artrosis mecánica, derrame/inflamación, menisco, dolor femoropatelar, tendón y dolor referido de cadera.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele al caminar, subir escaleras o levantarse y tiene rigidez matutina menor de 30 minutos?	Artrosis mecánica probable.	Reduce el patrón típico de OA sintomática.	Marcha, alineación, ROM, crepitación y RX en carga si cambia conducta.
¿Se le ha hinchado rápidamente, está caliente, tiene fiebre o duele incluso sin moverla?	Infección, cristales, hemartros o sinovitis activa.	Reduce urgencia inflamatoria, sin eliminarla.	Temperatura, derrame y artrocentesis/analítica según contexto.
¿Comenzó tras un giro y nota dolor en la interlínea, enganche o bloqueo verdadero?	Lesión meniscal mecánicamente relevante.	Reduce menisco mecánico; no excluye lesión degenerativa incidental.	Interlínea, McMurray/Thessaly y extensión completa.
¿Le duele por delante al bajar escaleras, ponerse en cuclillas o tras estar sentado?	Dolor femoropatelar.	Reduce patrón femoropatelar.	Step-down, sentadilla, control de cadera y rótula.
¿El dolor está exactamente en el tendón y aparece al saltar, correr o extender la rodilla?	Tendinopatía rotuliana o cuadricepsal.	Reduce tendón como generador principal.	Palpación, carga resistida y ecografía concordante.
¿Nota inestabilidad o que la rodilla se le va desde un traumatismo?	Lesión LCA/LCP/colaterales o inestabilidad funcional.	Reduce inestabilidad sintomática.	Lachman, sag/cajón posterior y valgo/varo.
¿También le duele la ingle, cojea o le cuesta ponerse el calcetín?	Dolor referido desde cadera.	Reduce cadera, pero no excluye hip-spine.	Rotación interna, FADIR/FABER y marcha.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Antes de infiltrar, una rodilla caliente o un derrame agudo sin explicación obliga a descartar infección, cristales o hemartros. El dolor medial puede proceder de la cadera.

2B. Rodilla: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Stroke / bulge	Con rodilla extendida, vaciar líquido medial hacia suprapatelar y barrer lateral hacia medial.	Onda/abombamiento medial: derrame pequeño.	Reduce derrame pequeño; no excluye mínima sinovitis.
Baloteo rotuliano	Comprimir receso suprapatelar y empujar rótula hacia fémur.	Rótula flota o golpea fémur: derrame moderado-grande.	No excluye derrame pequeño; usar stroke test.
McMurray + interlínea	Flexionar rodilla; rotar tibia y aplicar varo/valgo mientras se extiende, palpando interlínea.	Dolor habitual o clic palpable en interlínea: aumenta sospecha meniscal si la historia concuerda.	No descarta lesión meniscal; pesa más si tampoco hay bloqueo ni dolor focal.
Thessaly	Apoyo monopodal, rodilla a unos 20°; girar cuerpo/rodilla varias veces con apoyo.	Dolor de interlínea, catching o bloqueo: apoya menisco.	Rendimiento modesto; negativo no excluye. Evitar si dolor intenso/inestabilidad.
Lachman	Rodilla 20°-30°; estabilizar fémur y traccionar tibia hacia delante.	Mayor traslación y tope blando frente al lado sano: insuficiencia LCA.	Buen tope reduce rotura completa; no excluye parcial, dolor o defensa.
Sag + cajón posterior	A 90° observar caída posterior tibial; después empujar tibia hacia atrás.	Sag o traslación posterior aumentada: insuficiencia LCP.	Reduce rotura completa; lesiones parciales pueden pasar inadvertidas.
Valgo / varo	Aplicar estrés valgo y varo a 30° y repetir cerca de 0°.	Dolor/laxitud a 30°: colateral; laxitud a 0°: posible lesión multiligamentaria.	Estabilidad reduce lesión significativa; no excluye esguince leve doloroso.
Step-down / sentadilla	Descenso de escalón o sentadilla monopodal observando dolor, valgo y control pélvico.	Dolor anterior habitual y mal control: apoya dolor patelofemoral y déficit funcional.	No excluye patelofemoral; es prueba funcional, no de una estructura única.

SÍNTESIS CLÍNICA

Menisco: ninguna prueba aislada confirma; combinar historia de giro/bloqueo, interlínea y maniobras. Ligamentos: comparar siempre con el lado sano. Rodilla caliente o derrame agudo sin causa clara exige pensar antes en infección, cristales o hemartros.

2C. Rodilla: ecografía, derrame e infiltraciones

El color ámbar o seroso no excluye infección ni cristales: la indicación de análisis depende del contexto clínico.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Receso suprapatelar	Sin derrame significativo ni hipertrofia sinovial/hiperemia patológica.
Tendón cuadricipital y rotuliano	Continuidad, patrón fibrilar y grosor conservados; sin Doppler patológico.
Compartimento medial/lateral	Interlíneas, menisco periférico visible, extrusión, MCL/LCL y osteofitos.
Región anterior	Grasa de Hoffa, retináculos y recesos parapatelares según clínica.
Huevo poplíteo	Sin quiste de Baker ni colección; vasos identificados.
Limitación	La ecografía no excluye lesión intraarticular profunda ni sustituye RM cuando está indicada.

Decisión	Regla práctica	Expectativa realista
Artrocentesis	Medir volumen/aspecto; si infección/cristales posibles: recuento, cristales, Gram y cultivo. Documentar p. ej. "7 cc, amarillo-ámbar, transparente/turbio".	El aspecto orienta, no diagnóstica.
Corticoide IA	Puede aliviar a corto plazo una OA sintomática/sinovitis; individualizar diabetes, infección, cirugía próxima y repetición.	Semanas en muchos pacientes; no prometer duración.
Ácido hialurónico	No recomendado de rutina por AAOS/NICE; si se ofrece, explicar beneficio medio pequeño/incierto y coste.	No prometer 6-12 meses.
PRP	Puede mejorar dolor/función en algunos fenotipos de OA, pero evidencia/calidad y preparaciones heterogéneas.	No afirmar superioridad universal ni excluir solo por "avanzada" sin contexto.
Bloqueo genicular → RF	OA crónica refractaria, cirugía no indicada/rechazada o dolor persistente seleccionado; bloqueo pronóstico según protocolo.	Objetivo analgésico/funcional, no modificar artrosis.

PLAN BASE	Ejercicio de fuerza y aeróbico adaptado, pérdida de peso si procede, educación y AINE tópico como opción inicial en OA de rodilla. Fisioterapia 6-12 semanas con reevaluación funcional; ESWT se reserva para tendinopatías seleccionadas, no para la artrosis intraarticular. EMTT/inductiva: complemento opcional de evidencia limitada/emergente.
------------------	--

MENSAJE AL PACIENTE	La punción puede bajar el dolor y el derrame, pero la rodilla mejora de forma más duradera cuando usamos esa ventana para fortalecer, caminar mejor y reducir la carga total sobre la articulación.
----------------------------	---

2D. Rodilla: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
OA periférica	Diclofenaco gel 11,6 mg/g; 2-4 g, 3-4 veces/día.	7-14 días; puede prolongarse 2-4 semanas si eficaz y seguro.
Brote doloroso	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h; añadir omeprazol 20 mg/día si riesgo GI.	5-7 días; no combinar AINE.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días; retirar si no aporta.
OA con fenotipo central	Duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas; después 60 mg/día si tolera.	Ensayo 6-8 semanas; continuar solo si mejora dolor y función.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Artrocentesis + corticoide	Tras aspirar: betametasona depot 1 mL o triamcinolona 40 mg + lidocaína 1%/bupivacaína 0,25%.	Total 3-5 mL; no infiltrar hasta excluir infección cuando proceda.
Bloqueo diagnóstico IA	Lidocaína 1% o bupivacaína 0,25%, sin corticoide.	3-5 mL; repetir tarea a los 15-30 min.
Ácido hialurónico	Preparado comercial específico; no mezclar ni extrapolar dosis entre productos.	Habitualmente 2-6 mL según ficha técnica; no rutinario.
PRP	PRP autólogo según sistema validado; no mezclar con anestésico local ni corticoide.	Habitualmente 4-6 mL; protocolo y evidencia variables.

REHABILITACIÓN

Fuerza de cuádriceps y cadera, ejercicio aeróbico y control de peso/carga durante 8-12 semanas; fisioterapia 4-8 sesiones si requiere supervisión.

EVITAR

Infiltrar una rodilla caliente sin estudio, prometer 6-12 meses de respuesta, repetir corticoide por calendario o confundir PRP con regeneración de cartílago.

3A. Cadera: anamnesis dirigida

Localizar ingle, región lateral o nalga y preguntar por calcetín, coche, decúbito y síntomas lumbares.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿El dolor está en la ingle y le cuesta ponerse el calcetín, el zapato o entrar en el coche?	Origen coxofemoral: OA, labrum o FAI.	Reduce cadera intraarticular, sin excluirla.	Rotación interna, log-roll, FADIR/FABER y RX en carga.
¿Cojea o le duele al flexionar o girar la pierna hacia dentro?	OA u otra patología intraarticular.	Reduce OA rígida; no excluye labrum/FAI.	ROM comparativo, especialmente rotación interna.
¿Le duele en el lateral al dormir sobre ese lado o al estar de pie sobre una pierna?	Síndrome doloroso trocantérico/tendinopatía glútea.	Reduce GTPS, especialmente si tampoco duele a la palpación.	Palpación GT, abducción/derotación resistida y apoyo monopodal.
¿El dolor aparece al hacer fuerza para elevar la pierna o subirla al coche?	Iliopsoas o generador intraarticular.	Reduce irritabilidad del flexor, no cadera articular.	Stinchfield, flexión resistida y ecografía del iliopsoas.
¿Tiene dolor lumbar, hormigueos, debilidad o dolor que baja por la pierna?	Columna/radiculopatía; L2-L4 puede referir a ingle/rodilla medial.	Reduce origen neural objetivo.	SLR/femoral stretch, fuerza, sensibilidad y reflejo rotuliano.
¿Nota chasquido, bloqueo o dolor tras un giro/deporte?	Labrum/FAI, iliopsoas dinámico o cuerpo libre.	Reduce síntomas mecánicos, no lesión estructural.	FADIR, log-roll, maniobra dinámica e imagen si cambia conducta.
¿Tiene prótesis, fiebre, dolor nocturno nuevo o empezó tras una caída?	Infección, aflojamiento, fractura o complicación protésica.	Reduce alarma, no la elimina.	RX, analítica y Traumatología; no infiltrar hasta aclarar.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Dolor inguinal más pérdida de rotación interna aumenta la sospecha coxofemoral. El dolor lateral con decúbito/carga unipodal orienta a glúteos, y el déficit neurológico no debe atribuirse a la cadera.

3B. Cadera: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Rotación interna / log-roll	En supino, comparar rotación interna; para log-roll, rodar suavemente la pierna relajada en rotación interna/externa.	Dolor inguinal o restricción marcada: aumenta sospecha coxofemoral.	Reduce OA avanzada, pero no excluye labrum/FAI u otra patología intraarticular.
FADIR	Flexionar cadera 90°, aducir y rotar internamente de forma progresiva.	Dolor inguinal habitual: test sensible de patología intraarticular/FAI, poco específico.	Un negativo reduce FAI/intraarticular, sin excluirlo por completo.
FABER	Talón sobre rodilla contraria; estabilizar pelvis y descender suavemente la rodilla.	Dolor inguinal: cadera; posterior: SI/lumbopélvico; asimetría apoya restricción.	No excluye cadera ni SI; es localizador, no confirmatorio.
Stinchfield	Supino; elevar pierna recta 20°-30° contra resistencia.	Dolor inguinal: puede ser intraarticular o flexor de cadera; baja especificidad.	Reduce irritabilidad con carga, pero no descarta patología articular.
Palpación GT	Palpar facetas del trocánter mayor y tendones glúteos reproduciendo el dolor lateral habitual.	Dolor focal concordante: aumenta sospecha de GTPS; combinado con abducción resistida es más útil.	Junto con abducción resistida negativa reduce mucho la probabilidad de GTPS.
Abducción / derotación resistida	Resistir abducción; o desde flexión 90° y rotación externa, resistir vuelta a rotación interna.	Dolor lateral habitual: apoya tendinopatía glútea/GTPS; debilidad obliga a valorar rotura o nervio.	Combinado con palpación negativa hace GTPS menos probable.
Apoyo monopodal 30 s	Mantener apoyo sobre lado doloroso hasta 30 s; observar pelvis y dolor.	Dolor lateral habitual apoya GTPS; caída pélvica sugiere déficit abductor, no etiología única.	Reduce GTPS muy irritable; no excluye formas leves.
Cribado lumbar	SLR si dolor posterior; femoral stretch y reflejo rotuliano si ingle/muslo anterior.	Dolor neural concordante o déficit/reflejo asimétrico: apoya origen lumbar L2-S1.	No elimina hip-spine; cadera y columna pueden coexistir.

SÍNTESIS CLÍNICA

Para dolor lateral, la combinación palpación del trocánter + abducción resistida es más útil que etiquetar 'bursitis'. Para hip-spine dudoso, la respuesta a infiltración intraarticular con tarea antes/después discrimina mejor que un PENG.

3C. Cadera: ecografía, bloqueo discriminativo y plan

Para diferenciar cadera-columna, la infiltración intraarticular con anestésico es más apropiada que usar el PENG como “test del generador”.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Receso anterior	Cápsula sin distensión significativa; contorno cabeza-cuello y cortical visibles.
Iliopsoas	Tendón/bursa sin distensión; dinámica si resalte.
Región lateral	Glúteo medio/mínimo con continuidad; bursas no distendidas; Doppler si procede.
Aductores/recto femoral	Explorar según localización, especialmente en dolor deportivo.
Limitación	Ecografía no valora adecuadamente cartilago profundo, labrum completo ni médula ósea.

Escenario	Prueba/intervención	Lectura
Hip-spine dudoso	Infiltración intraarticular ecoguiada con anestésico local, documentando tarea provocadora antes/después; corticoide solo si también se busca tratamiento.	Alivio claro apoya componente intraarticular; respuesta parcial puede significar generadores múltiples.
OA leve-moderada sintomática	Ejercicio/fisioterapia y AINE si seguro. Corticoide IA puede dar alivio corto.	AAOS desaconseja HA de cadera: no supera placebo en promedio.
Dolor intenso de cadera / perioperatorio	PENG es un bloqueo analgésico de ramas articulares anteriores.	No sustituye al bloqueo intraarticular diagnóstico y puede no cubrir toda la cápsula.
Dolor trocantérico concordante	Carga de abductores; infiltración peribursal/peritendinosa selectiva si dolor impide rehabilitar.	Evitar inyección intratendinosa; el efecto del corticoide suele ser corto.
Prótesis dolorosa	RX inicial + analítica/Trauma según sospecha; otras imágenes guiadas por hallazgos.	No infiltrar hasta excluir infección/complicación protésica.

PLAN BASE	Fortalecimiento de abductores/extensores, movilidad, reentrenamiento de marcha y control de carga durante 6-12 semanas. En OA, el objetivo es mantener actividad; en GTPS, progresar carga del tendón y reducir compresión lateral nocturna.
------------------	--

MENSAJE AL PACIENTE	La infiltración puede ayudarnos a saber cuánto dolor procede realmente de la cadera y, si funciona, abrir una ventana para recuperar marcha y fuerza. Si no cambia su dolor habitual, debemos buscar otro generador en lugar de repetirla.
----------------------------	--

3D. Cadera: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
OA / dolor mecánico	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días; revisar marcha, sueño y tarea elegida.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días; utilidad limitada en OA como monoterapia.
GTPS	Diclofenaco gel 11,6 mg/g: 2-4 g, 3-4 veces/día sobre región lateral.	7-14 días junto a reducción de compresión y carga progresiva.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Diagnóstico intraarticular	Lidocaína 1% o bupivacaína 0,25%, sin corticoide.	3-5 mL; tarea de cadera antes/después.
Terapéutico intraarticular	Betametasona depot 1-2 mL o triamcinolona 40 mg + anestésico local.	Total 5-8 mL; imagen, asepsia y aspiración negativa.
PENG	Ropivacaína 0,2% o bupivacaína 0,25%; sin corticoide de rutina.	10-20 mL (habitual 15 mL); posible bloqueo motor, no prueba IA específica.
Bursa trocantérica	Betametasona depot 1 mL o triamcinolona 20 mg + lidocaína 1%.	Total 4-6 mL; evitar tendón glúteo.

REHABILITACIÓN

Fuerza de abductores, marcha, movilidad y control de carga 8-12 semanas; 4-8 sesiones de fisioterapia cuando haya cojera, miedo o déficit técnico.

EVITAR

HA intraarticular en cadera, corticoide intratendinoso glúteo o interpretar un PENG positivo como confirmación automática de cadera intraarticular.

4A. Lumbar: anamnesis dirigida

La postura aporta pistas, pero el diagnóstico depende de distribución, alivio, neurología y patrón de carga.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Empeora sentado, al inclinarse hacia delante o al levantar peso?	Patrón discogénico posible.	Reduce ese patrón; no excluye disco sintomático.	Movimientos repetidos y observar centralización/periferización.
¿Empeora al extender o girar el tronco, o al estar de pie quieto?	Patrón facetario posible.	Reduce patrón facetario, pero no descarta faceta.	Extensión-rotación; MBB si se plantea RF, no por exploración aislada.
¿El dolor baja por la pierna con hormigueo, descarga o empeora al toser/estornudar?	Dolor radicular/radiculopatía.	Reduce radicular; no excluye dolor referido.	SLR/slump o femoral stretch, miotomas, sensibilidad y reflejos.
¿Le aparecen dolor, pesadez o debilidad en piernas al caminar o estar de pie y tiene que pararse?	Estenosis con claudicación neurógena.	Reduce estenosis sintomática; no la imagen anatómica.	Distancia de marcha, alivio sentado/flexionado, neurología y pulsos.
¿Mejora al sentarse, inclinarse hacia delante o apoyarse en el carro?	Refuerza claudicación neurógena.	Si solo mejora al detenerse, considerar claudicación vascular.	Pulsos, piel, marcha y comparación con bicicleta/flexión si procede.
¿Señala el dolor bajo la EIPS y empeora al girarse en cama o apoyar una pierna?	Complejo sacroilíaco posible.	Reduce SI; revisar cadera, lumbar y glúteo.	Fortin y clúster de provocación SI.
¿Tiene pérdida de fuerza progresiva, anestesia en silla de montar o cambios recientes de esfínteres?	Cauda equina o déficit neurológico grave.	Reduce alarma inmediata, no otras banderas rojas.	Neurología completa, RM y valoración urgente.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Flexión y extensión son pistas, no diagnósticos. Estenosis clínica exige síntomas con marcha/bipedestación y alivio postural; radiculopatía exige concordancia neuroanatómica y neurológica.

4B. Lumbar: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Movimientos repetidos	Repetir flexión o extensión lumbar y mapear si el dolor se centraliza o se desplaza distalmente.	Centralización apoya preferencia direccional; perifерización obliga a reducir/cambiar movimiento y revisar raíz.	Sin cambio no excluye disco ni identifica faceta; solo falta una respuesta direccional clara.
Extensión-rotación	De pie, extender e inclinar/rotar hacia el lado doloroso con control.	Dolor axial local puede apoyar patrón facetario, pero también carga otras estructuras.	No descarta faceta; ni positivo ni negativo sustituyen un MBB cuando se plantea RF.
SLR / Lasègue	Supino, elevar pierna con rodilla extendida; usar dorsiflexión cervical/tobillo para diferenciación estructural.	Reproduce dolor radicular habitual bajo la rodilla, típicamente 30°-70°: apoya L5/S1.	Reduce radiculopatía discal L5/S1, pero no excluye ni valora bien L2-L4.
SLR cruzado	Elevar la pierna asintomática con rodilla extendida.	Provoca dolor radicular en la pierna sintomática: bastante específico para hernia discal relevante.	Es frecuente que sea negativo; no excluye radiculopatía.
Slump	Sentado: flexión torácico-cervical, extensión de rodilla y dorsiflexión; liberar cuello para diferenciar.	Reproduce síntomas habituales y cambian al liberar tensión: apoya mecanosensibilidad neural.	Reduce mecanosensibilidad, pero no excluye compresión radicular.
Femoral stretch	Prono o lateral: flexionar rodilla y extender suavemente cadera evitando hiperlordosis.	Dolor anterior de muslo habitual: apoya raíces L2-L4/femoral.	Reduce radiculopatía alta; no excluye dolor de cadera o psoas.
Motor-reflejos-marcha	Talones L4-L5, puntillas S1; fuerza segmentaria, sensibilidad, rotuliano y aquileo comparativos.	Déficit miotómico o reflejo asimétrico concordante: radiculopatía verdadera y cambia prioridad.	Neurología normal no excluye dolor radicular sin pérdida axonal.
Marcha/flexión + pulsos	Medir distancia de marcha y alivio sentado/inclinado; explorar pulsos y repetir con bicicleta si procede.	Piernas al estar de pie/caminar y alivio con flexión: claudicación neurógena; pulsos pobres sugieren vascular.	No excluye estenosis radiológica; cuestiona que sea el generador sintomático.

SÍNTESIS CLÍNICA

Radiculopatía se apoya en concordancia de distribución, neurodinamia y déficit/reflejo, no en dolor de pierna aislado. El dolor facetario no se confirma con extensión-rotación: si la RF es una opción, la prueba relevante es el bloqueo de ramos mediales.

4C. Lumbar: imagen, bloqueos y escalada

No existe una ecografía lumbar “normal” capaz de descartar hernia, estenosis o dolor discogénico; úsala para sonoanatomía y guía, no para diagnosticar el disco.

Problema	Intervención seleccionada	Regla de seguimiento
Dolor facetario crónico probable	Tras manejo conservador, MBB con pequeño volumen y registro funcional. Si respuesta claramente concordante según protocolo → valorar RF de ramos mediales.	No hacer RF solo por dolor a la extensión o artrosis en RM.
Radiculopatía aguda/subaguda grave concordante	Epidural puede reducir dolor/discapacidad principalmente a corto plazo. La vía (caudal/interlaminar/transforaminal) depende del nivel, objetivo, imagen y seguridad.	No prometer 6 meses ni repetir por calendario; repetir solo si beneficio clínico relevante y plan funcional.
Estenosis con claudicación	Ejercicio flexión-tolerante, marcha asistida/bici, medicación; epidural tiene beneficio limitado y no suele mejorar dolor a corto plazo de forma importante.	Derivar si deterioro neurológico, función inaceptable o correlación quirúrgica.
Fracaso tras epidural	Revisar diagnóstico, nivel, adherencia, déficit e imagen. PRF de DRG es opción especializada de evidencia limitada, no paso automático a los 4 meses.	Cirugía por déficit/progresión o dolor incapacitante con compresión concordante, no solo por duración.

GUÍA DE IMAGEN

Ecografía: identificar sacro, láminas, facetas, transversas, multífido, hiato y vasos; documentar diana y aguja. En epidural caudal, la ecografía confirma entrada por hiato pero no demuestra distribución cefálica. En técnicas epidurales/foraminales y RF, seguir estándares de imagen, contraste y seguridad del centro.

FARMACOLOGÍA

AINE oral corto si es seguro. NICE desaconseja gabapentinoides, benzodiacepinas y corticoide oral para ciática; evitar opioides crónicos. El ciclo fijo de prednisona no debe figurar como pauta universal.

MENSAJE AL PACIENTE

La inyección epidural no recoloca el disco ni evita necesariamente una cirugía. Su objetivo es disminuir el dolor radicular durante semanas o meses en algunos pacientes para recuperar sueño, marcha y ejercicio mientras vigilamos la fuerza y la evolución.

4D. Lumbar: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Axial mecánico	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días; actividad y ejercicio desde el inicio.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días; no cronificar si no mejora función.
Neuropático seleccionado	Duloxetine 30 mg/día 1-2 semanas y después 60 mg/día; alternativa: amitriptilina 10 mg/noche, subir 10 mg cada 7 días hasta 25-50 mg.	Ensayo 6-8 semanas; elegir uno, no combinarlos de entrada.
Ciática	No usar de rutina prednisona, benzodiacepinas ni gabapentinoides; opioide solo rescate excepcional con fecha de fin.	Revisar fuerza y evolución en 1-2 semanas si cuadro agudo relevante.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
MBB lumbar	Lidocaína 1-2% o bupivacaína 0,25-0,5%; sin corticoide.	0,3-0,5 mL por ramo; registrar tarea y duración.
Epidural transforaminal	Dexametasona no particulada 10 mg + salino o anestésico local de baja concentración según protocolo.	Total 1,5-3 mL por raíz; contraste y control radiológico según estándar.
Epidural interlaminar	Dexametasona 10 mg + suero salino 0,9% con o sin anestésico local.	Total 4-6 mL; adaptar a nivel, estenosis y protocolo.
Epidural caudal	Dexametasona 10 mg + salino 0,9% con o sin ropivacaína 0,1-0,2%.	Total 10-20 mL; ecografía confirma hiato, no extensión cefálica.

REHABILITACIÓN

Actividad graduada, fuerza de tronco/cadera y exposición a flexión o extensión según patrón durante 6-12 semanas; 4-8 sesiones si precisa guía.

EVITAR

RF sin bloqueo pronóstico concordante, corticoide particulado transforaminal como opción rutinaria, repetir epidural por calendario o superar dosis acumulada de anestésico local.

5A. Cuello: anamnesis dirigida

Separar dolor axial facetario, radiculopatía, mielopatía y hombro periférico antes de plantear una técnica.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿El dolor se queda en cuello/occipital/escápula y empeora al mirar arriba o girar?	Patrón facetario cervical posible.	Reduce patrón facetario; no descarta faceta.	ROM, extensión-rotación; MBB si crónico y se plantea RF.
¿El dolor baja por el brazo con hormigueo, quemazón o descarga?	Radiculalgia/radiculopatía cervical.	Reduce radicular; pensar en hombro o dolor referido.	Spurling, distracción, ULTT1 y neurología C5-T1.
¿Empeora al mover el cuello, toser o estornudar?	Refuerza irritación/compresión radicular.	Reduce mecanosensibilidad cervical, no la excluye.	Clúster cervical y distribución por raíz.
¿Al poner la mano del lado doloroso sobre la cabeza disminuye el dolor del brazo?	Bakody positivo: apoya radiculopatía cervical.	No excluye radiculopatía; si duele hombro, valorar manguito.	Bakody, distracción y exploración de hombro si procede.
¿Le duele sobre todo al elevar o mover el hombro y el cuello influye poco?	Generador periférico de hombro.	Reduce hombro aislado; pueden coexistir ambos.	Arco, manguito, AC y ecografía de hombro.
¿Ha perdido fuerza, se le caen objetos o nota adormecimiento persistente?	Radiculopatía con déficit o posible médula.	Reduce déficit objetivo; no dolor radicular.	Fuerza, sensibilidad, reflejos y RM si concordante.
¿Tiene torpeza de manos, marcha inestable o urgencia/incontinencia nueva?	Mielopatía cervical hasta demostrar lo contrario.	Reduce alarma, pero no excluye mielopatía inicial.	Hoffmann, clonus, hiperreflexia, marcha y RM prioritaria.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Antes de infiltrar una cervicobraquialgia hay que documentar fuerza, sensibilidad y reflejos. Bakody es una pregunta/manobra de alivio; cualquier pista de médula cambia el algoritmo.

5B. Cuello: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Spurling	Extender, inclinar y rotar hacia lado sintomático; aplicar compresión axial suave solo si es seguro.	Reproduce dolor/parestesias radicales habituales en brazo: aumenta probabilidad de radiculopatía.	No excluye radiculopatía por sensibilidad limitada.
Distracción cervical	Supino o sentado, sujetar occipucio/mentón y aplicar tracción axial suave.	Alivia claramente el dolor braquial habitual: apoya compresión radicular.	No excluye radiculopatía; el síntoma puede no responder a tracción.
ULTT1 mediano	Depresión escapular, abducción, supinación, extensión muñeca/dedos, rotación externa y extensión de codo; inclinar cuello para diferenciar.	Reproduce síntomas neuroanatómicos que cambian con cuello: mecanosensibilidad neural; positivo aislado es poco específico.	Un ULTT1 negativo reduce la probabilidad de radiculopatía cervical.
Rotación <60°	Girar activamente hacia el lado sintomático y estimar/medir el rango sin compensación.	Menos de 60° forma parte del clúster de radiculopatía; no diagnostica sola.	Más de 60° resta un elemento al clúster, pero no excluye.
Bakody	El paciente coloca la mano del lado sintomático sobre la cabeza, abduciendo el hombro.	Disminuyen dolor irradiado o parestesias: Shoulder Abduction Relief Sign positivo, apoya radiculopatía cervical.	No excluye radiculopatía. Si provoca dolor local de hombro, explorar manguito/BSASD.
Arm Squeeze	Comprimir moderadamente el tercio medio del brazo sobre bíceps/tríceps y comparar con AC/subacromial.	Dolor claramente mayor en brazo medio: apoya origen cervical frente a hombro.	No descarta origen cervical ni confirma hombro; integrar con neurología.
Neurología C5-T1	Fuerza, sensibilidad y reflejos bicipital, estilogartrial y tricipital, comparando lados.	Déficit miotómico, dermatómico o reflejo reducido concordante: radiculopatía y posible lesión axonal.	Normal no excluye radiculalgia sin déficit objetivo.
Hoffmann	Sujetar dedo medio relajado y chasquear distalmente la falange/uña hacia flexión.	Flexión/adducción involuntaria de pulgar/índice: signo piramidal; con clínica, sospechar mielopatía.	No excluye mielopatía; puede ser unilateral, bilateral o incluso incidental.
Clonus + marcha	Dorsiflexión brusca sostenida del tobillo; después marcha normal, talón-punta y tándem.	Clonus sostenido o marcha espástica/inestable: posible afectación medular; RM/derivación prioritaria.	No excluye mielopatía inicial; pesan torpeza manual, hiperreflexia y progresión.

SÍNTESIS CLÍNICA

Para radiculopatía, usar clúster: historia concordante + Spurling/distracción/ULTT/rotación y neurología. Bakody es una prueba de alivio, no de provocación. Cualquier signo de médula cambia el algoritmo y desaconseja infiltrar sin aclarar el diagnóstico.

5C. Cervical: bloqueos y tratamiento seguro

La ecografía ayuda a visualizar raíces, vasos y ramos mediales en manos expertas, pero no sustituye la RM ni todos los controles de seguridad.

Escenario	Opción	Límite / seguridad
Dolor facetario crónico	MBB cervical ecoguiado en operadores expertos o fluoroscópico; respuesta concordante → RF con técnica e imagen apropiadas.	Evitar sedación si invalida respuesta; no hacer RF por RM degenerativa aislada.
Radiculopatía sin déficit progresivo	Educación, actividad graduada, fisioterapia; epidural cervical en casos seleccionados tras RM y consentimiento.	Beneficio sobre todo corto; complicaciones raras pero graves.
Bloqueo selectivo de raíz	Puede tener valor diagnóstico/terapéutico especializado.	La ecografía identifica vasos, pero no garantiza ausencia de flujo intravascular/foraminal; seguir protocolo estricto.
Déficit progresivo o mielopatía	Derivación a cirugía de columna/neurocirugía.	No retrasar con ciclos repetidos de corticoide o infiltraciones.

FARMACOLOGÍA	AINE corto si no hay contraindicaciones. No existe una pauta universal de prednisona 30 mg descendente para toda cervicobraquialgia; la evidencia de corticoide oral es limitada y deben ponderarse diabetes, infección, HTA, osteoporosis y diagnóstico. Neuromoduladores solo si fenotipo neuropático claro y balance beneficio-riesgo.
FISIOTERAPIA	6-8 sesiones iniciales repartidas en 6-10 semanas si precisa supervisión: educación, exposición gradual, movilidad, control cervicoescapular, fuerza y neurodinamia seleccionada. Tracción puede ser coadyuvante en algunos pacientes; evitar dependencia de terapias pasivas.
MENSAJE AL PACIENTE	Buscamos reducir la irritación del nervio y vigilar que conserve fuerza. Una infiltración puede facilitar la recuperación, pero si aparece debilidad progresiva, torpeza de manos o alteración de la marcha cambia la prioridad y hay que valorar cirugía.

5D. Cuello: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Axial mecánico	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días; mantener movilidad tolerada.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Neuropático seleccionado	Duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas y después 60 mg/día; alternativa amitriptilina 10 mg/noche, subir semanalmente hasta 25-50 mg.	Ensayo 6-8 semanas; revisar TA, tolerancia, función y retirada gradual.
Cervicobraquialgia	No adoptar prednisona descendente como pauta universal; decidir caso a caso tras descartar mielopatía/infección.	Revisión precoz si déficit, dolor progresivo o sueño muy alterado.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
MBB cervical	Lidocaína 1-2% o bupivacaína 0,25-0,5%; sin corticoide.	0,2-0,3 mL por ramo; volumen bajo para especificidad.
Epidural cervical interlaminar	Dexametasona no particulada 10 mg + suero salino, con o sin anestésico local según protocolo.	Total 3-5 mL; RM previa y técnica radiológica estandarizada.
Transforaminal / raíz	Dexametasona no particulada 10 mg + salino 0,9%.	Total 1-2 mL; nunca particulado; contraste y vigilancia vascular.
RF cervical	Lidocaína 1% para piel; lidocaína 2% 0,5-1 mL por diana antes de lesión según protocolo.	Sin corticoide rutinario; estimulación y control de imagen.

REHABILITACIÓN

Movilidad, resistencia cervical y cintura escapular, neurodinamia seleccionada y exposición gradual 6-10 semanas; 4-8 sesiones supervisadas.

EVITAR

Epidural sin RM o con mielopatía, corticoide particulado cervical transforaminal, sedación profunda que invalide el bloqueo diagnóstico o técnicas para retrasar cirugía ante déficit progresivo.

6A. Codo: anamnesis dirigida

Localizar el máximo dolor y distinguir carga tendinosa, nervio cubital, articulación y rotura traumática.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele por fuera al agarrar, levantar una taza o extender la muñeca?	Epicondialgia lateral.	Reduce extensor común como generador principal.	Palpación epicóndilo, Cozen, Mill y Maudsley.
¿El dolor está más distal en el antebrazo y empeora al extender el tercer dedo?	Túnel radial/supinador frente a epicondialgia.	Reduce túnel radial.	Localización precisa, Maudsley y exploración radial/cervical.
¿Le duele por dentro al flexionar la muñeca, pronar o lanzar?	Flexor-pronador; en lanzador, valorar UCL.	Reduce patrón medial por carga.	Carga flexor-pronadora y moving valgus.
¿Tiene hormigueo en 4.º-5.º dedos, sobre todo con el codo flexionado o por la noche?	Neuropatía cubital en túnel cubital.	Reduce neuropatía cubital, no la excluye.	Tinel, flexión mantenida, fuerza intrínsecos y sensibilidad.
¿Notó chasquido, hematoma y pérdida de fuerza tras una carga súbita?	Rotura distal de bíceps o tríceps.	Reduce rotura completa aguda.	Hook test/defecto palpable, ecografía y Trauma preferente.
¿Tiene rigidez, derrame, bloqueo o dolor durante todo el arco?	OA, sinovitis o cuerpo libre.	Reduce generador articular difuso.	ROM, derrame, RX; si caliente/fiebre, descartar infección.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

El dolor lateral con agarre suele ser tendinoso, pero la localización distal, las parestesias o la pérdida brusca de fuerza obligan a cambiar el diagnóstico diferencial.

6B. Codo: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Cozen	Codo flexionado, antebrazo pronado; resistir extensión y desviación radial de muñeca con puño cerrado.	Dolor focal en epicóndilo lateral: apoya tendinopatía lateral.	Reduce epicondialgia, pero no excluye cuadros leves ni túnel radial.
Mill	Pronación, flexión de muñeca y extensión pasiva del codo para estirar extensores.	Dolor focal epicondíleo habitual: apoya origen extensor común.	No descarta tendinopatía; usar con Cozen y palpación.
Maudsley	Resistir extensión del tercer dedo con codo extendido y antebrazo pronado.	Dolor epicondíleo apoya extensores; dolor 3-5 cm distal puede orientar a túnel radial.	No excluye ninguna de ambas y no localiza por sí solo.
Moving valgus	Hombro abducido/rotado externamente; aplicar valgo mientras se extiende codo de flexión máxima a unos 30°.	Dolor medial entre 70°-120° o laxitud: sospechar UCL en lanzador.	Reduce lesión sintomática importante, pero no excluye parcial.
Tinel cubital	Percutir suavemente nervio cubital detrás del epicóndilo medial.	Parestesias habituales hacia 4.º-5.º dedos: apoya neuropatía cubital.	No la excluye por sensibilidad limitada.
Flexión mantenida	Mantener codo en flexión máxima, muñeca neutra, hasta 60 s; puede añadirse presión cubital.	Reproduce parestesias cubitales: aumenta sospecha de túnel cubital.	No excluye; completar fuerza intrínsecos, sensibilidad y subluxación dinámica.
Hook test	Codo 90°, antebrazo supinado; intentar enganchar con el índice el tendón distal del bíceps desde lateral.	No se palpa/engancha cordón: alta sospecha de rotura completa distal.	Tendón palpable reduce rotura completa, pero no excluye parcial.

SÍNTESIS CLÍNICA

Epicondialgia se apoya en dolor focal reproducido con carga, no en imagen aislada. Parestesias o debilidad obligan a explorar nervio cubital, radial y cuello. Hook test anormal tras trauma requiere derivación preferente.

6C. Codo: ecografía, intervención y plan

Evitar infiltrar dentro del tendón o del nervio. La ecografía sirve para concordancia estructural y guía segura.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Origen extensor común	Patrón fibrilar, grosor y cortical del epicóndilo; sin rotura, calcificación ni Doppler patológico.
Origen flexor-pronador	Continuidad fibrilar y entesis medial; relación con UCL.
Bíceps distal / tríceps	Continuidad hasta inserción, sin defecto ni retracción; maniobra dinámica si precisa.
Nervio cubital	Área, fascículos, surco y estabilidad dinámica; sin aumento focal ni subluxación sintomática.
Recesos articulares / ligamentos	Sin derrame, sinovitis ni cuerpo libre; UCL y complejo lateral según ventana.

Escenario	Opción	Después / límite
Epicondialgia lateral	Educación y carga progresiva extensora; terapia manual como coadyuvante. ESWT en crónica seleccionada.	8-12 semanas antes de declarar fracaso; el corticoide puede aliviar pronto pero empeorar recurrencia/resultado intermedio.
Tendinopatía persistente	Valorar procedimiento peritendinoso o PRP con decisión compartida; evidencia heterogénea.	Nunca prometer regeneración ni infiltrar intratendinoso; cirugía excepcional.
Dolor articular concordante	Infiltración intraarticular ecoguiada diagnóstica/terapéutica en OA o sinovitis seleccionada.	Si aspiración: analizar ante sospecha de infección/cristales.
Neuropatía cubital	Modificación postural, férula nocturna y neurodinamia; bloqueo perineural solo en casos seleccionados.	Déficit/atrofia, EMG grave o fracaso → cirugía; evitar lesión intraneural.

MENSAJE AL PACIENTE

El tendón necesita recuperar capacidad de carga. El alivio pasivo puede ayudar, pero la mejoría duradera depende de progresar fuerza y tolerancia sin picos bruscos.

6D. Codo: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional.
Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Epicondilalgia	Diclofenaco gel 11,6 mg/g; 2-4 g, 3-4 veces/día.	7-14 días como apoyo al programa de carga.
Brote intenso	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250 mg/12 h si es seguro.	3-5 días; evitar prolongar en tendinopatía.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Neuropatía cubital	No hay AINE o neuromodulador de rutina que corrija compresión; analgesia según fenotipo y férula postural.	Revisar fuerza/sensibilidad en 4-6 semanas o antes si progresa.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Intraarticular	Betametasona depot 0,5-1 mL o triamcinolona 10-20 mg + lidocaína 1%.	Total 2-3 mL; solo generador articular concordante.
Bloqueo cubital	Lidocaína 1% o ropivacaína 0,2%; sin corticoide de rutina.	2-4 mL perineural; visualizar nervio y evitar intraneural.
Epicondileo diagnóstico	Lidocaína 1% peritendinosa, sin corticoide.	0,5-1 mL en plano superficial; interpretar con tarea de agarre.
PRP peritendinoso	PRP autólogo según sistema; no mezclar con anestésico local o corticoide.	2-3 mL; evidencia heterogénea y decisión compartida.

REHABILITACIÓN

Carga progresiva de extensores/flexores, agarre y cadena proximal durante 8-12 semanas; 4-6 sesiones para enseñar progresión.

EVITAR

Corticoide intratendinoso, múltiples infiltraciones epicondíleas, punción intraneural o demorar derivación ante rotura distal del bíceps o atrofia cubital.

7A. Mano-muñeca: anamnesis dirigida

Separar tendón, articulación, ligamento y nervio; en trauma, la radiografía puede pesar más que la ecografía.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele en la estiloides radial al usar el pulgar, hacer pinza o coger a un bebé?	De Quervain.	Reduce 1.er compartimento como generador.	Palpación, Finkelstein verdadero/WHAT y ecografía de vaina.
¿Se le duermen pulgar, índice y medio por la noche y mejora al sacudir la mano?	Túnel carpiano.	Reduce CTS típico, pero no lo excluye.	CTS-6, Durkan/Phalen/Tinel, sensibilidad y fuerza tenar.
¿Le duele la base del pulgar al abrir botes, girar llaves o hacer pinza?	OA CMC1/rizartrosis.	Reduce CMC1 sintomática.	Palpación, grind, pinza y RX.
¿Le duele el lado cubital al girar una llave, apoyarse o desviar la muñeca?	TFCC, DRUJ, ECU o carga ulnocarpiana.	Reduce patrón cubital mecánico.	Fovea/TFCC load, DRUJ y ECU dinámico.
¿Empezó tras una caída y duele en tabaquera o dorso radial?	Escafoides o lesión escafolunar.	Reduce trauma óseo/ligamentario, sin excluirlo.	Tabaquera, Watson, RX; inmovilizar si alta sospecha aunque RX inicial normal.
¿Se le bloquea o salta un dedo al flexionarlo y extenderlo?	Dedo en resorte/polea A1.	Reduce bloqueo mecánico de A1.	Palpar nódulo/salto y ecografía dinámica.
¿Ha perdido fuerza, nota atrofia, deformidad, herida o la articulación está caliente?	Déficit neural, rotura, fractura, infección o artritis aguda.	Reduce alarma inmediata.	Exploración neurovascular, RX/eco y derivación prioritaria.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

La distribución nocturna orienta al nervio mediano; la tarea de pinza localiza De Quervain o CMC1; tras trauma no se filtra antes de excluir fractura o inestabilidad.

7B. Mano-muñeca: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Finkelstein verdadero	Sujetar pulgar y desviar pasivamente la muñeca hacia cubital sin encerrar el pulgar en el puño.	Dolor focal en estiloides radial/1.er compartimento: apoya De Quervain.	Reduce De Quervain; no excluye fase leve. Evitar confundir con Eichhoff, más doloroso y menos específico.
WHAT	Muñeca en hiperflexión; paciente abduce/extiende pulgar contra resistencia.	Dolor habitual sobre 1.er compartimento: apoya De Quervain.	Hace menos probable De Quervain, sin excluirlo.
Phalen	Juntar dorsos de manos con muñecas flexionadas hasta 60 s.	Parestesias habituales en territorio mediano: apoya túnel carpiano.	No excluye; sensibilidad y especificidad son moderadas/variables.
Durkan	Comprimir directamente el nervio mediano sobre túnel carpiano hasta 30 s.	Reproduce parestesias mediano: apoya túnel carpiano.	No excluye. Integrar con síntomas nocturnos, fuerza tenar y sensibilidad.
Tinel mediano	Percutir suavemente sobre nervio mediano en túnel carpiano.	Descarga hacia pulgar-índice-medio: apoya irritación mediana; relativamente más confirmatorio que excluyente.	Negativo frecuente: no descarta túnel carpiano.
CMC grind	Estabilizar trapecio; comprimir axialmente el 1.er metacarpiano y rotarlo suavemente.	Dolor basal y crepitación: apoya OA CMC1 sintomática.	No excluye OA; correlacionar con palpación, pinza y RX.
Fovea / carga TFCC	Palpar entre estiloides cubital, FCU y pisiforme; añadir carga axial y desviación/rotación cubital.	Dolor cubital habitual: apoya lesión TFCC/ligamentos ulnotriquetrales, no una lesión específica.	No excluye TFCC; explorar DRUJ, ECU y solicitar imagen si cambia manejo.
Watson	Presionar tubérculo escafoideo mientras la muñeca pasa de desviación cubital-extensión a radial-flexión.	Clunk doloroso/dorsal y subluxación: sospecha inestabilidad escafolunar.	No excluye lesión; en trauma, RX y valoración especializada pesan más.

SÍNTESIS CLÍNICA

Túnel carpiano no se confirma ni se descarta con una sola maniobra: integrar distribución nocturna, Durkan/Phalen/Tinel, fuerza tenar y estudios electrodiagnósticos cuando cambien conducta. En trauma, no infiltrar antes de excluir fractura o inestabilidad.

7C. Mano-muñeca: ecografía, bloqueos y plan

La ecografía dinámica es especialmente útil en tendones, nervio mediano, gangliones y guía de vainas/articulaciones.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Nervio mediano	Morfología fascicular y área en entrada del túnel comparada con antebrazo; sin aumento focal. No diagnosticar por un único umbral.
Compartimentos extensores	Tendones centrados, fibrilares y móviles; sin líquido, engrosamiento ni tabiques relevantes en 1.º compartimento.
Flexores / poleas	Continuidad y deslizamiento; sin tenosinovitis. Polea A1 si dedo en resorte.
CMC1 / radiocarpiana / DRUJ	Derrame, sinovitis, osteofitos y cortical visible; correlacionar con RX.
ECU, ganglión y partes blandas	Estabilidad dinámica del ECU, quiste y relación neurovascular; el TFCC se valora solo parcialmente por US.

Escenario	Intervención posible	Regla práctica
De Quervain	Férula pulgar, carga y corticoide ecoguiado en vaina si persiste.	Identificar subcompartimentos; evitar inyección intratendinosa y advertir atrofia/hipopigmentación.
Túnel carpiano	Férula nocturna; corticoide ecoguiado para alivio corto o puente.	AAOS 2024: no aporta beneficio a largo plazo; déficit/atrofia o grave → cirugía.
Dedo en resorte	Infiltración en torno a polea A1 tras confirmar indicación.	Diabetes reduce respuesta y eleva glucemia; cirugía si bloqueo persistente/fracaso.
OA CMC1	Ortesis, adaptación de pinza y ejercicio; infiltración intraarticular seleccionada.	Beneficio variable y temporal; no repetir automáticamente.
Dolor cubital / lesión ligamentaria	Bloqueo articular diagnóstico solo si cambia conducta.	Inestabilidad o trauma concordante → mano/Trauma y RM/TC según sospecha.

MENSAJE AL PACIENTE

La infiltración puede calmar una vaina o un nervio, pero no corrige una inestabilidad ni sustituye la descompresión si ya existe pérdida de fuerza.

7D. Mano-muñeca: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
De Quervain / CMC1	Diclofenaco gel 11,6 mg/g; 2 g, 3-4 veces/día.	7-14 días junto a ortesis y adaptación de carga.
Brote articular	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250 mg/12 h si es seguro.	3-5 días.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Túnel carpiano	Férula nocturna neutra; los AINE no descomprimen el nervio.	Ensayo 6-8 semanas si no hay déficit/atrofia.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
De Quervain	Triamcinolona 10 mg + lidocaína 1% 0,5 mL.	Total 1-1,5 mL en vaina; identificar subcompartimentos.
Túnel carpiano	Triamcinolona 20 mg + lidocaína 1% 0,5-1 mL.	Total 1-2 mL; fuera del nervio, alivio generalmente temporal.
Dedo en resorte	Triamcinolona 10 mg + lidocaína 1% 0,5 mL.	Total aproximado 1 mL alrededor de polea A1.
CMC1	Betametasona depot 0,25-0,5 mL o triamcinolona 5-10 mg + anestésico local.	Total 0,5-1 mL; confirmar posición intraarticular.

REHABILITACIÓN

Ortesis específica, movilidad y carga progresiva de pinza/agarre 6-8 semanas; terapia de mano 3-6 sesiones si precisa adaptación laboral.

EVITAR

Inyección intraneural o intratendinosa, repetir corticoide para túnel carpiano como solución a largo plazo o infiltrar antes de excluir fractura/inestabilidad.

8A. Tobillo-pie: anamnesis dirigida

Pedir que señale con un dedo el máximo dolor y relacionarlo con primeros pasos, terreno, calzado, carrera y traumatismo.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele el talón medial en los primeros pasos de la mañana o tras estar sentado?	Fasciopatía plantar.	Reduce patrón típico, no la excluye.	Palpación tubérculo medial, Windlass y dorsiflexión.
¿Le duele o está rígido el Aquiles al correr, saltar o ponerse de puntillas?	Tendinopatía aquilea.	Reduce Aquiles como generador principal.	Palpación, heel rise y ecografía; Thompson si trauma.
¿Ha tenido esguinces repetidos o inseguridad en terreno irregular?	Inestabilidad lateral crónica.	Reduce inestabilidad sintomática.	Cajón anterior, talar tilt, peroneos y propiocepción.
¿Le duele por dentro y nota que el arco se hunde o no puede ponerse de puntillas?	Disfunción del tibial posterior.	Reduce insuficiencia avanzada.	Heel rise monopodal, too-many-toes y ecografía.
¿Tiene dolor profundo anterior, rigidez, derrame, bloqueo o catching tras un esguince?	OA, impingement o lesión osteocondral.	Reduce generador articular mecánico.	Lunge, ROM, RX en carga y RM si bloqueo/OLT.
¿Nota quemazón u hormigueo en la planta o detrás del maléolo medial?	Túnel tarsal o dolor neural; considerar S1.	Reduce neuropatía tibial, no la excluye.	Tinel tarsal, neuro S1 y ecografía de nervio/masas.
¿El dolor eléctrico está entre los dedos y empeora con calzado estrecho?	Neuroma interdigital/Morton.	Reduce neuroma clínico.	Mulder, squeeze y diferenciar bursitis/MTP.
¿Aumentó de golpe la carga y ahora tiene dolor óseo focal que progresa?	Fractura por estrés.	Reduce estrés, pero una RX inicial normal no lo excluye.	Carga focal, Ottawa si trauma y RM ante alta sospecha.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

En trauma aplicar reglas de Ottawa. El primer paso matutino orienta a fascia; terreno irregular a inestabilidad/subtalar; bloqueo profundo tras esguince obliga a pensar en lesión osteocondral.

8B. Tobillo-pie: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Cajón anterior	Rodilla flexionada, tobillo ligera flexión plantar; estabilizar tibia y traccionar calcáneo hacia delante.	Traslación/laxitud o tope blando frente al lado sano: lesión ATFL/inestabilidad lateral.	Reduce inestabilidad importante; en fase aguda dolor/defensa pueden falsearlo.
Talar tilt	Estabilizar tibia y aplicar inversión del retropié, comparando lados.	Mayor inclinación/laxitud: lesión CFL ± complejo lateral.	No excluye esguince parcial; comparar siempre lados.
Squeeze sindesmosis	Comprimir tibia y peroné juntos en tercio medio de pierna.	Dolor distal sobre sindesmosis: apoya esguince alto.	No lo excluye; combinar con rotación externa y mecanismo.
Rotación externa	Rodilla 90°, estabilizar pierna y rotar externamente el pie en neutro/dorsiflexión.	Dolor sindesmótico o medial: sospechar sindesmosis/deltoideo.	No excluye lesión parcial; imagen si persiste o carga imposible.
Thompson	Prono, pies fuera de camilla; comprimir masa gemelar observando flexión plantar.	Ausencia o clara reducción de flexión plantar: rotura de Aquiles hasta demostrar lo contrario.	Flexión conservada reduce rotura completa, pero no excluye parcial.
Heel rise monopodal	Elevar talón repetidamente sobre una pierna observando altura, dolor e inversión del retropié.	Incapacidad/dolor medial o no inversión: disfunción tibial posterior; dolor Aquiles orienta tendón.	No excluye tendinopatía leve; cuantificar repeticiones y comparar.
Windlass	En carga o sentado, dorsiflexionar pasivamente el hallux y palpar fascia.	Reproduce dolor medial de talón/tensa fascia: apoya fasciopatía plantar.	No excluye; la historia de primeros pasos sigue siendo clave.
Tinel tarsal	Percutir nervio tibial detrás del maléolo medial.	Parestesias hacia planta en distribución habitual: apoya túnel tarsal.	No excluye; explorar S1, tibial posterior y causas locales.
Mulder	Comprimir metatarsianos y pinzar espacio interdigital dorsal-plantar.	Clic/dolor eléctrico localizado hacia dedos: apoya neuroma interdigital.	No excluye; descartar bursitis intermetatarsal, MTP y metatarsalgia.

SÍNTESIS CLÍNICA

En trauma agudo aplicar reglas de Ottawa antes de asumir 'esguince'. Un test ligamentario negativo precoz puede ser falso por dolor o defensa: reexplorar. Dolor focal óseo progresivo con RX normal mantiene la sospecha de fractura por estrés.

8C. Tobillo-pie: ecografía, bloqueos y plan

La ecografía define tendón, fascia, ligamento, derrame y nervio superficial; no excluye lesión osteocondral ni fractura por estrés.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Receso anterior / articulación	Sin derrame/sinovitis; cortical y osteofitos visibles; impingement dinámico si procede.
Ligamentos laterales	ATFL/CFL continuos y tensos; comparación dinámica si está indicada.
Tendones	Aquiles, peroneos, tibial posterior, flexores y extensores: fibrilaridad, grosor, vaina y estabilidad dinámica.
Fascia plantar	Grosor y ecotextura en origen, sin rotura; correlación focal. Evitar diagnosticar solo por milímetros.
Nervios / antepié	Tibial y ramas, espacio interdigital, bursas y masas; Doppler cuando aporte.

Escenario	Plan	Límite
Fasciopatía plantar	Estiramiento fascia/gemelo, fuerza pie-tobillo, taping/ortesis seleccionada; ESWT si crónica.	Corticoide solo excepcional y ecoguiado: riesgo de rotura/atrofia grasa.
Aquiles	Carga mecánica progresiva excéntrica o pesada-lenta; adaptar insercional.	No infiltrar corticoide intratendinoso; rotura → derivación.
OA tobillo	Calzado/ortesis, fuerza, peso y actividad; infiltración con anestésico ± corticoide seleccionada.	AAOS 2026 desaconseja HA sola (fuerte) y PRP (moderada) en OA sintomática.
Articulación / vaina / neuroma	Bloqueo ecoguiado diagnóstico si el resultado cambia tratamiento; infiltración terapéutica individualizada.	Registrar tarea antes/después; evitar lesión neural/tendinosa y series automáticas.

MENSAJE AL PACIENTE

El objetivo es recuperar tolerancia a caminar y cargar. Las ondas pueden ayudar en algunas tendinopatías crónicas, pero el tratamiento central sigue siendo dosificar carga, fuerza y calzado.

8D. Tobillo-pie: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Dolor periférico	Diclofenaco gel 11,6 mg/g; 2-4 g, 3-4 veces/día.	7-14 días; reevaluar si persiste después de 7 días.
Brote articular	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Tendinopatía	La medicación no sustituye carga; usar analgesia solo si permite caminar y rehabilitar.	Plan de carga 8-12 semanas.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Tibiotalar	Betametasona depot 1 mL o triamcinolona 20-40 mg + lidocaína 1%/bupivacaína 0,25%.	Total 3-5 mL; no usar HA/PRP de rutina en OA de tobillo.
Subtalar	Betametasona depot 0,5 mL o triamcinolona 10-20 mg + anestésico local.	Total 2-3 mL; confirmar articulación.
Morton	Betametasona depot 0,25-0,5 mL o triamcinolona 10 mg + lidocaína 1%.	Total 1-2 mL; evitar placa plantar y paquete neurovascular.
Túnel tarsal	Lidocaína 1% o ropivacaína 0,2%; sin corticoide de rutina.	2-4 mL perineural; no intraneural.
Fascia plantar	Si excepcional: triamcinolona 10 mg + lidocaína 1%.	Total 1-2 mL superficial a fascia; riesgo de rotura/atrofia.

REHABILITACIÓN

Fuerza pie-tobillo, gemelo/sóleo, fascia, propiocepción y calzado durante 8-12 semanas; 4-8 sesiones según déficit. ESWT si fascia/Aquiles crónicos.

EVITAR

Corticoide intratendinoso en Aquiles, punción plantar repetida, infiltrar sospecha de fractura por estrés u ofrecer HA/PRP como estándar de OA de tobillo.

9A. Sacroilíacas: anamnesis dirigida

La anamnesis aumenta o reduce plausibilidad, pero no confirma la sacroilíaca sin exploración concordante.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Puede señalar con un dedo el dolor justo por debajo y medial a la EIPS?	Fortin positivo: aumenta plausibilidad del complejo SI.	Hace SI menos probable.	Repetir localización y clúster de provocación.
¿Empeora al levantarse, girarse en la cama, subir escaleras o apoyar una sola pierna?	Carga sacroilíaca/posterior.	Reduce patrón mecánico SI.	Distraction, thigh thrust, compression, sacral thrust y Gaenslen.
¿Empezó durante embarazo/postparto, tras trauma o después de una fusión lumbar?	Contexto que aumenta plausibilidad SI.	Reduce esos factores contextuales, no SI.	Estabilidad pélvica, discrepancia, marcha y antecedentes quirúrgicos.
¿El dolor está en la ingle o en el lateral al acostarse sobre ese lado?	Cadera intraarticular o GTPS como imitadores.	Reduce esos imitadores.	Rotación interna/FADIR o palpación GT/abducción resistida.
¿Baja por la pierna con hormigueo, pérdida de fuerza o cambia al mover la espalda?	Origen lumbar/radicular.	Reduce radiculopatía, no dolor referido.	SLR/slump, neurología y movimientos lumbares.
¿Tiene rigidez matutina prolongada, dolor nocturno que mejora al levantarse, psoriasis o uveítis?	Patrón inflamatorio/espondiloartritis.	Reduce patrón inflamatorio.	Cribado reumatológico, analítica/imágenes y derivación según contexto.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Una localización Fortin y un patrón de carga aumentan sospecha; varias pruebas de provocación negativas ayudan más a descartarla que varias positivas a confirmarla.

9B. Sacroilíacas: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Fortin finger	Pedir que señale con un dedo el punto máximo de dolor; repetir para confirmar localización.	Punto repetido inmediatamente inferomedial a EIPS: aumenta plausibilidad del complejo SI.	Hace SI menos probable, pero no la excluye; revisar lumbar, cadera y glúteo.
Distraction	Supino; aplicar presión posterolateral sostenida sobre ambas EIAS.	Reproduce dolor posterior habitual: prueba de provocación SI concordante.	Una negativa aislada no excluye; cuenta dentro del clúster.
Thigh thrust	Supino; cadera flexionada 90°, estabilizar sacro y aplicar fuerza axial por el fémur.	Reproduce dolor habitual posterior: apoya SI y suele ser una de las maniobras más útiles.	Reduce algo probabilidad; no excluye por sí sola.
Compression	Decúbito lateral sobre lado asintomático; comprimir cresta ilíaca superior hacia camilla.	Reproduce dolor SI posterior habitual: prueba concordante.	Negativa aislada no excluye; integrar con las demás.
Sacral thrust	Prono; aplicar presión anterior sostenida sobre centro del sacro.	Reproduce dolor habitual SI/posterior: suma al clúster.	No excluye; puede ser negativa aunque otras sean positivas.
Gaenslen	Supino al borde: una cadera en flexión máxima y la otra extendida; aplicar torsión suave.	Dolor posterior habitual en el lado evaluado: suma al clúster; localizar el dolor.	No excluye y puede provocar cadera/lumbar; interpretar con cautela.

SÍNTESIS CLÍNICA

Interpretar el conjunto, no cada prueba: varias pruebas negativas hacen menos probable que la SI sea el generador. Tres o más positivas concordantes elevan la sospecha, pero el valor confirmatorio es limitado; si la decisión es intervencionista, usar bloqueo diagnóstico con tarea funcional.

9C. Sacroilíacas: bloqueos, radiofrecuencia y plan

No existe una plantilla ecográfica diagnóstica de SI normal. La ecografía aporta sonoanatomía y guía; la confirmación intraarticular exige control apropiado.

Ecografía procedural	Documentar
Landmarks	Sacro, ilion, EIPS, forámenes sacros y porción posterior accesible de la articulación.
Seguridad	Vasos con Doppler, profundidad, trayecto, punta de aguja y fármaco/volumen.
Limitación	La guía ecográfica no siempre confirma distribución intraarticular; seguir protocolo local de imagen/contraste cuando el objetivo lo requiera.

Escenario	Intervención	Cómo decidir
Sospecha intraarticular	Bloqueo con anestésico local, pequeño volumen y prueba funcional antes/después; corticoide solo si indicación terapéutica.	Las infiltraciones IA tienen validez diagnóstica para dolor intraarticular, no para todo el complejo posterior.
Dolor posterior persistente	Bloqueos de ramas laterales como prueba pronóstica y RF en paciente seleccionado.	Usar criterios y técnica del protocolo; no indicar por exploración o RM aislada.
Fracaso conservador	Revisar diagnóstico, rehabilitación y comorbilidades; fusión solo en casos estrictamente seleccionados.	No escalar si el bloqueo no cambia el dolor habitual o la tarea provocadora.

PLAN BASE	Educación, estabilización lumbopélvica, fuerza de cadera, marcha y control de cargas 6-12 semanas; cinturón pélvico en casos seleccionados, sobre todo periparto. Tratar factores de sueño, miedo y desacondicionamiento.
-----------	---

MENSAJE AL PACIENTE	El bloqueo es una prueba y, a veces, un tratamiento temporal. Si no cambia su dolor habitual al hacer la tarea que lo provoca, repetiremos la valoración en vez de insistir sobre la sacroilíaca.
---------------------	---

9D. Sacroilíacas: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional.
Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Dolor mecánico	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días junto a movimiento y estabilización.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Patrón inflamatorio	No pautar solo analgesia repetida: solicitar estudio y derivación reumatológica según contexto.	Prioridad según síntomas sistémicos y actividad inflamatoria.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Diagnóstico intraarticular	Lidocaína 1-2% o bupivacaína 0,25-0,5%; sin corticoide.	Total 1-2 mL; pequeño volumen y tarea antes/después.
Terapéutico IA	Betametasona depot 0,5-1 mL o triamcinolona 20-40 mg + anestésico local.	Total 1,5-2,5 mL; confirmar distribución intraarticular.
Ramas laterales	Lidocaína 1-2% o bupivacaína 0,25-0,5%; sin corticoide.	0,3-0,5 mL por diana; prueba pronóstica antes de RF.
RF ramas laterales	Lidocaína 1% cutánea; lidocaína 2% 0,5-1 mL por diana antes de lesión.	Sin corticoide rutinario; parámetros y número de lesiones según protocolo.

REHABILITACIÓN

Estabilización lumbopélvica, fuerza de cadera, marcha y control de carga 6-12 semanas; cinturón pélvico seleccionado, especialmente periparto.

EVITAR

Usar una imagen degenerativa como diagnóstico, sobrepasar la pequeña capacidad articular, RF sin bloqueo pronóstico o repetir infiltración cuando no cambia el dolor habitual.

10A. Dolor nociplástico: anamnesis dirigida

Reconocer un fenotipo de procesamiento alterado sin convertirlo en diagnóstico de exclusión ni en 'dolor psicológico'.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿El dolor dura más de tres meses y se ha extendido a varias zonas o cambia mucho de localización?	Distribución regional/generalizada compatible con fenotipo nociplástico.	Reduce patrón generalizado; no excluye nociplástico regional.	Mapa corporal, WPI/SSS y búsqueda de generadores locales.
¿Le duele el roce, una presión leve o estímulos que antes no dolían?	Alodinia/hiperalgesia e hipersensibilidad.	No excluye nociplástico; puede faltar.	Comparación táctil, pinprick y presión en zonas locales/remotas.
¿El dolor parece mucho mayor o más persistente de lo esperado por la lesión o la imagen?	Desacople clínico que aumenta plausibilidad nociplástica.	Mayor concordancia periférica; no excluye coexistencia.	Revisar concordancia de imagen, función y respuesta a tratamientos locales.
¿Duerme mal, se levanta sin descanso o tiene fatiga y niebla mental?	Carga multisistémica frecuente en fibromialgia/nociplástico.	Reduce esa carga, pero no excluye el mecanismo.	WPI/SSS, sueño, apnea/RLS, medicación y función.
¿También tiene cefalea, intestino irritable o sensibilidad marcada a luz, ruido u olores?	Comorbilidades que aumentan plausibilidad.	No excluye; no son obligatorias.	Historia multisistémica sin atribuir automáticamente todo al dolor.
¿Los bloqueos o tratamientos locales han dado respuestas breves, variables o desproporcionadas?	El generador periférico puede no explicar todo el cuadro.	Respuesta local reproducible apoya componente periférico coexistente.	Revisar tareas antes/después y evitar escalar por hallazgos incidentales.
¿Hay quemazón, descargas, déficit focal, rigidez inflamatoria, fiebre o pérdida de peso?	Neuropatía, inflamación o bandera roja que puede coexistir y debe priorizarse.	Reduce esos imitadores, sin confirmar nociplástico.	Neurología, DN4/painDETECT y estudio dirigido según sospecha.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

No existe una pregunta ni un test confirmatorio aislado. El fenotipo se apoya en duración, distribución, hipersensibilidad y síntomas asociados tras valorar mecanismos nociceptivos, inflamatorios y neuropáticos.

10B. Dolor nociplástico: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Mapa + WPI/SSS	Marcar todas las zonas dolorosas y puntuar extensión, fatiga, sueño y síntomas cognitivos.	Dolor generalizado y carga sintomática alta apoyan fibromialgia/fenotipo nociplástico tras excluir imitadores.	Puntuación baja reduce fibromialgia generalizada, no excluye nociplástico regional.
Alodinia táctil	Rozar piel con algodón/cepillo suave en área dolorosa, contralateral y zona distante.	Dolor ante estímulo inocuo, sobre todo extendido: apoya hipersensibilidad; también puede ser neuropática.	No excluye nociplástico; muchos pacientes no presentan alodinia.
Pinprick / hiperalgesia	Comparar pinchazo romo estandarizado en lados y zonas distantes, sin lesionar piel.	Respuesta desproporcionada o extendida: apoya amplificación, pero una distribución neural sugiere neuropatía.	No excluye sensibilización; la respuesta depende de contexto y técnica.
Presión comparativa	Aplicar presión gradual similar en punto doloroso, contralateral y zona remota; detener al primer dolor.	Umbral bajo generalizado apoya hipersensibilidad difusa; focal puede reflejar lesión local.	No excluye nociplástico y no sustituye algometría/QST formal.
Exploración neurológica	Fuerza, reflejos, sensibilidad, coordinación y marcha según territorio clínico.	Déficit focal/dermatómico obliga a priorizar neuropatía, raíz o médula, aunque pueda coexistir nociplástico.	Normal reduce lesión neurológica objetiva, pero no confirma nociplástico.
DN4 / painDETECT	Cuestionario más exploración breve para rasgos neuropáticos cuando hay quemazón, descargas o alodinia.	Cribado positivo apoya componente neuropático; no demuestra lesión ni excluye coexistencia nociplástica.	Reduce componente neuropático, no lo elimina ni diagnostica nociplástico.
CSI	Cuestionario de síntomas relacionados con sensibilización y comorbilidades.	Puntuación alta abre conversación sobre carga multisistémica; no es biomarcador ni diagnóstico.	Puntuación baja no excluye nociplástico; usar solo como apoyo.

SÍNTESIS CLÍNICA

No existe un 'test positivo de dolor nociplástico'. El diagnóstico es fenotípico: dolor >3 meses, distribución/hipersensibilidad y comorbilidades, con evaluación suficiente de generadores nociceptivos, inflamatorios y neuropáticos. Un hallazgo local puede coexistir.

10C. Dolor nociplástico: tratamiento y seguimiento

La prioridad es reducir amenaza, recuperar función y mejorar autorregulación. Los procedimientos repetidos sobre hallazgos incidentales suelen empeorar la iatrogenia.

Componente	Intervención	Dosificación inicial
Educación	Explicar mecanismos, seguridad del movimiento y plan compartido	Mensajes breves y repetidos; evitar 'todo está en su cabeza'.
Ejercicio	Aeróbico, fuerza y movilidad graduados según tolerancia	Inicio bajo, 2-3 días/semana; progresar tiempo o carga, no ambos a la vez.
Sueño y ritmo	Horario, luz, actividad, tratamiento de apnea/RLS si sospecha	Pacing flexible: evitar ciclos auge-caída y reposo total.
Psicoterapia	CBT o ACT centrada en dolor y función	Integrarla como tratamiento del sistema de dolor, no como descarte.
Fármacos	Duloxetina o amitriptilina seleccionadas; revisar beneficio funcional	Una variable cada vez; retirar si no hay beneficio. Evitar opioides crónicos.
Multidisciplinar	Dolor, AP, fisio, psicología y trabajo/social según impacto	Indicar cuando hay alta discapacidad, comorbilidad o fracaso fragmentado.

Procedimiento / modalidad	Papel
Bloqueos e infiltraciones	No diagnostican nociplástico. Usar solo si existe generador periférico concordante y el resultado cambiará una conducta concreta.
Ecografía / RM	No hay plantilla diagnóstica. Evitar perseguir hallazgos degenerativos incidentales.
ESWT / EMTT / inductiva	No son tratamiento central del fenotipo; solo para una lesión periférica bien definida, con expectativas realistas.

SEGUIMIENTO	Revisar cada 4-8 semanas al inicio: sueño, pasos/actividad, tarea elegida, participación, miedo y medicación. Una reducción de dolor modesta puede ser éxito si mejora función y autonomía.
--------------------	---

MENSAJE AL PACIENTE	Su dolor es real. El sistema que lo produce se ha vuelto demasiado sensible. No buscamos una lesión oculta en cada zona, sino bajar esa sensibilidad y recuperar poco a poco sueño, confianza, fuerza y vida diaria.
----------------------------	--

10D. Dolor nociplástico: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Primera opción	Duloxetina 30 mg/día durante 1-2 semanas; después 60 mg/día si tolera.	Ensayo 6-8 semanas; continuar solo con beneficio funcional. Retirada gradual 2-4 semanas.
Alternativa nocturna	Amitriptilina 10 mg por la noche; subir 10 mg cada 7 días hasta 25-50 mg según tolerancia.	Valorar a 4-8 semanas; reducir gradualmente al suspender.
Dolor local coexistente	Paracetamol o AINE solo por generador nociceptivo periférico concordante, no para el fenotipo global.	Curso breve de 3-7 días.
No ofrecer de rutina	Opioides, gabapentinoides, benzodiacepinas, corticoides o combinaciones sedantes para dolor crónico primario.	Revisar y deprescribir de forma gradual cuando proceda.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Bloqueo 'nociplástico'	No existe fármaco ni volumen diagnóstico.	No realizar.
Generador periférico coexistente	Usar el injectate específico de esa ficha solo si clínica y tarea son concordantes.	Menor volumen eficaz; un resultado negativo obliga a revisar, no a repetir.
Puntos gatillo	Si indicación miofascial clara: lidocaína 0,5-1%, sin corticoide.	0,5-1 mL por punto; limitar número y dosis total; evidencia modesta.

REHABILITACIÓN

Ejercicio aeróbico y fuerza con inicio bajo 2-3 días/semana, sueño, pacing, CBT/ACT y plan multidisciplinar; revisión cada 4-8 semanas.

EVITAR

Escalada de infiltraciones por hallazgos incidentales, combinar duloxetina y amitriptilina de entrada, perseguir EVA cero o interpretar el dolor como psicológico.

11. Prescripción rápida: fármacos y terapia física

Usar la dosis mínima eficaz, durante el menor tiempo posible, y registrar función objetivo. Comprobar alergias, embarazo, riñón, hígado, úlcera, anticoagulación, HTA/IC y medicación concomitante.

Opción	Uso orientativo	Guardarraíl
Paracetamol	Rescate breve cuando AINE no es apropiado; 500-1.000 mg cada 8 h según paciente.	Máximo conservador 3 g/día; reducir/evitar en hepatopatía, alcohol de riesgo o fragilidad. No confiar como monoterapia eficaz en OA/lumbalgia.
AINE tópico	Primera opción farmacológica en OA de rodilla y dolor periférico superficial.	Revisar piel, anticoagulación/riesgo sistémico y duplicidad con AINE oral.
AINE oral	Ibuprofeno 400 mg/8 h o naproxeno 250 mg/12 h, habitualmente 3-7 días, si es seguro.	No combinar AINE; valorar IBP. Evitar/individualizar en ERC, úlcera, IC, HTA descontrolada, anticoagulación.
Duloxetina	Dolor neuropático/nociplástico crónico seleccionado: 30 mg/d y valorar 60 mg/d.	No es pauta rutinaria para ciática aguda; vigilar tolerancia, TA, hígado e interacciones serotoninérgicas.
Amitriptilina	Dolor neuropático y sueño: inicio bajo, p. ej. 10 mg nocturno, titulación lenta.	Carga anticolinérgica, QT, glaucoma, retención; precaución especial en mayores.
Gabapentinoides	Reservar para indicaciones neuropáticas apropiadas, con ajuste renal.	No ofrecer de rutina para ciática; sedación, edema, caídas, dependencia/retirada gradual.
Opioides	Excepcional rescate agudo con fecha de fin.	Evitar en dolor musculoesquelético crónico y combinar con sedantes.

Terapia	Dónde encaja	Dónde no
Fisioterapia activa	Base en OA, manguito, GTPS, columna; sesiones según complejidad y programa domiciliario medible.	No prescribir "10 sesiones" sin objetivos, progresión ni reevaluación.
ESWT	Tendinopatía calcificante del manguito y algunas tendinopatías crónicas seleccionadas.	No es tratamiento estándar de radiculopatía, estenosis ni OA intraarticular.
EMTT / Magnetolith	Coadyuvante opcional; un RCT reciente sugiere beneficio corto en varios trastornos degenerativos.	Evidencia aún pequeña/heterogénea; no prometer regeneración ni sustituir ejercicio.
Terapia inductiva / PEMF	Puede modular dolor en algunos pacientes; considerar si bajo riesgo y objetivo claro.	No debe retrasar diagnóstico, carga progresiva o derivación.

12. Seguimiento y mensajes clínicos

Cada intervención debe nacer con una medida basal, una fecha de revisión y una decisión prevista para cada resultado.

Momento	Registrar	Decisión
Antes	NRS/EVA, sueño, medicación, tarea provocadora, distancia de marcha, fuerza/ROM y objetivo del paciente.	¿Qué resultado mínimo justificaría repetir/escalar?
15-30 min tras bloqueo diagnóstico	Misma tarea provocadora y porcentaje de alivio; evitar preguntas vagas.	Concordante, parcial o negativo; anotar duración esperada del anestésico.
48-72 h	Reacción postpunción, glucemia si riesgo, signos de infección/neurológicos.	Instrucciones claras de alarma y contacto.
2-6 semanas	Dolor, función, sueño, carga y adherencia a ejercicio.	Mantener, progresar, revisar diagnóstico o derivar.
6-12 semanas	Cambio clínicamente importante y objetivos alcanzados.	No repetir técnica ineficaz; escalar solo si diagnóstico sigue concordante.

GUIÓN UNIVERSAL	“El objetivo de esta técnica es aliviar el dolor y comprobar cuánto procede de esta estructura. Si responde, usaremos esa ventana para recuperar movimiento, fuerza, sueño y actividad. Si no responde, no significa que su dolor no sea real: significa que debemos revisar el generador en vez de repetir el mismo tratamiento.”
-----------------	--

TRAS ARTROCENTESIS	“He extraído ____ cc de líquido de aspecto ____ (transparente/turbio; amarillo-ámbar/hemático). El aspecto por sí solo no identifica la causa. Si existe sospecha de infección o cristales, lo enviaremos a analizar antes de decidir el tratamiento definitivo.”
--------------------	---

OA DE RODILLA	“El corticoide puede aliviar a corto plazo. El ácido hialurónico tiene un beneficio medio incierto y no se recomienda de rutina; el PRP puede ayudar a algunos pacientes, pero tampoco regenera el cartílago. Elegiremos según su perfil, evidencia, coste y objetivo.”
---------------	---

ROTURA DE MANGUITO	“El PRP no cose ni regenera una rotura completa. Puede tener un efecto analgésico en algunos escenarios, pero si hay debilidad o una rotura relevante debemos valorar el tamaño, la función y si necesita opinión quirúrgica.”
--------------------	--

13. Depuración de los ejemplos iniciales

Estas correcciones se integran en las fichas para evitar reglas demasiado deterministas.

Borrador inicial	Versión segura para la ficha
"Hawkins = bursa; Neer = supra"	Hawkins y Neer provocan dolor subacromial; no localizan de forma fiable bursa frente a tendón.
"FABER ++++ = cadera"	Interpretar localización: ingle apoya cadera; posterior puede ser SI/lumbopélvico. Integrar rotación interna, FADIR, marcha e imagen.
"PENG positivo demuestra cadera"	PENG es analgésico periarticular. Para hip-spine, preferir infiltración intraarticular con prueba funcional antes/después.
"Caudal alivia 6 meses; si dura 4 meses → PRF DRG"	La epidural ofrece beneficio principalmente corto y variable. Reevaluar antes de repetir; PRF de DRG no es escalón automático.
"Prednisona 30 mg descendente para cervicobraquialgia"	No usar como pauta universal; evidencia limitada, contraindicaciones y necesidad de descartar déficit/mielopatía.
"HA 6-12 meses; PRP mejor a un año"	No prometer duración ni superioridad. HA no se recomienda de rutina en rodilla y se desaconseja en cadera; PRP tiene evidencia limitada/heterogénea.
"PRP repara rotura completa del supra"	No regenera ni repara una rotura completa. La guía AAOS 2025 no apoya uso rutinario en tendinopatía/rotura parcial y considera no indicado rutinariamente en rotura completa no operada.
"Dolor 7-9 = bloqueo"	La intensidad contribuye, pero se decide con función, sueño, duración, diagnóstico, banderas rojas, alternativas y preferencias.
"Líquido ámbar = benigno"	El aspecto macroscópico no excluye infección ni cristales; analizar cuando el contexto lo exige.

14. Referencias esenciales y actualización

Fuentes seleccionadas para las decisiones que más modifican el borrador. Revisar protocolos locales y nuevas guías antes de aplicar dosis o técnicas.

1. [NICE NG59. Low back pain and sciatica in over 16s.](#)
2. [AAN 2025. Epidural steroids for cervical/lumbar radicular pain and stenosis.](#)
3. [Cohen et al. 2020. Consensus lumbar facet intervention guidelines.](#)
4. [Hurley et al. 2021. Consensus cervical facet intervention guidelines.](#)
5. [Thoomes et al. 2018. Diagnostic value of cervical radiculopathy tests.](#)
6. [Zhao et al. 2024. Evidence-based shoulder examination for rotator cuff tears.](#)
7. [Leblanc et al. 2015. Diagnostic accuracy of tests for anterior knee instability.](#)
8. [Dhillon et al. 2025. Diagnostic accuracy of hip physical examination tests.](#)
9. [Kinsella et al. 2024. Diagnostic test cluster for greater trochanteric pain syndrome.](#)
10. [Khorami et al. 2021. Guideline recommendations for lumbosacral radicular pain diagnosis.](#)
11. [Nee et al. 2022. Reliability and performance of SLR and crossed SLR.](#)
12. [Karanasios et al. 2022. Diagnostic tests for lateral elbow tendinopathy.](#)
13. [Núñez de Arenas-Arroyo et al. 2022. Provocation tests for carpal tunnel syndrome.](#)
14. [Wu et al. 2018. Finkelstein versus Eichhoff for De Quervain.](#)
15. [Schwieterman et al. 2013. Diagnostic accuracy of ankle/lower-leg special tests.](#)
16. [Saueressig et al. 2021. Diagnostic accuracy of SI provocation test clusters.](#)
17. [AAOS 2025. Management of Rotator Cuff Injuries.](#)
18. [Desmeules et al. 2025. Rotator cuff tendinopathy CPG.](#)
19. [Jain et al. 2017. Diagnostic accuracy of rotator cuff tests.](#)
20. [AAOS 2021. Management of Osteoarthritis of the Knee.](#)
21. [NICE NG226. Osteoarthritis in over 16s.](#)
22. [AAOS 2023. Management of Osteoarthritis of the Hip.](#)
23. [Maldonado et al. 2020. Diagnostic utility of guided intra-articular hip injections.](#)
24. [ESSR. Technical guidelines for musculoskeletal ultrasound.](#)
25. [Hollander et al. 2025/2026. Randomized sham-controlled EMTT trial.](#)
26. [Lucado et al. 2022. Lateral Elbow Pain CPG.](#)
27. [AAOS 2024. Management of Carpal Tunnel Syndrome.](#)
28. [Koc et al. 2023. Heel Pain—Plantar Fasciitis CPG.](#)
29. [Chimenti et al. 2024. Midportion Achilles Tendinopathy CPG.](#)
30. [AAOS 2026. Management of Ankle Osteoarthritis.](#)
31. [McCormick et al. 2025. Consensus guidelines on sacroiliac joint complex pain.](#)
32. [Kosek et al. 2021. Clinical criteria for chronic nociplastic musculoskeletal pain.](#)
33. [NICE NG193. Chronic primary and secondary pain in over 16s.](#)
34. [Benzon et al. 2025. Use and safety of corticosteroid injections in joints and MSK soft tissue.](#)
35. [Benzon et al. 2024/2026. Corticosteroids for adult chronic pain interventions and peripheral nerve blocks.](#)

36. [AEMPS-CIMA. Celestone Cronodose: composición y dosificación intraarticular por tamaño.](#)
37. [AEMPS-CIMA. Fichas técnicas de paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, duloxetina y amitriptilina.](#)

**CONTROL DE
VERSIÓN**

Versión 2.3: convierte la anamnesis de cada área en preguntas literales con significado de la respuesta positiva, valor de la negativa y exploración siguiente. Mantiene la exploración guiada, pautas, injectates y volúmenes de la V2.2. Adaptar siempre a ficha técnica y protocolo local.